三、输血原则

①同型输血

②自体输血：收集患者自身血液、然后将浓缩红细胞回输给本人，不仅节约库存血，而且非常安全，不会出现与免疫相关的输血并发症（如溶血、发热、过敏），适合外伤性脾破裂、异位妊娠破裂等

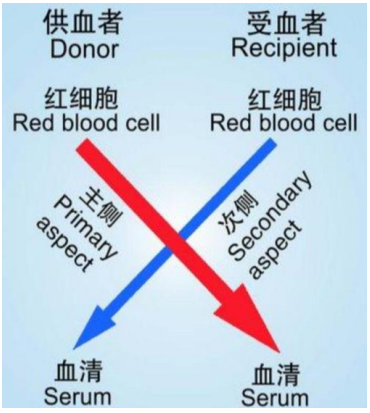
血库

外伤性肝破裂,还会有胆汁,不能自体输血

③成分输血如浓缩红

④当失血量＞30%→1/2 浓缩红+1/2 全血三全凌汤圆（馅和皮各一半）

⑤必须进行交叉配血

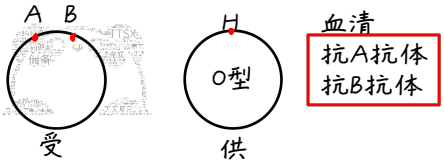


输血是为了供血者的红细胞,所以供血者红细胞是主侧

主侧（供血者红细胞+受血者血清）凝集→不能输血

我们要的是供血者的红细胞、所以供血者红细胞一定是主侧

次侧（受血者红细胞+供血者血清）凝集→紧急情况可缓慢、少量（＜200ml）、低浓度（抗体效价＜1:200）输血（当输血量较大时供血者血清的抗体没有被受血者的血清足够稀释，此时受血者的红细胞会被广泛凝集）



若主侧不发生凝集、而次侧发生凝集，则配血基本符合，如：

将 O 型血 输给 其他血型的人	过时观点认为 O 型红细胞没有 A、B 抗原，所以 O 型的红细胞给谁都好（万能供血者），但 O 型血清有抗 A、抗 B 抗体，所以 O 型的血清逮谁溶谁（除了 O 型以外）
AB 型血的人 接受 其他血型的血	过时观点认为 AB 型的血清没有抗 A、抗 B 抗体，所以 AB 型的血清不会溶其他的红细胞（万能受血者），但 AB 型红细胞有 A、B 抗原，所以 AB 型接受其他人输血时必然被溶（除了 AB 型以外）
Rh+者接受 Rh-者的血	有 D 抗原的人接受熊猫血，因为熊猫曾经接触过 D 抗原、所以有 D 抗体，因此导致受者红细胞凝集（交叉配血次侧）

